HagaZiekenhuis

# Buikwandcorrectie

In overleg met uw behandelend arts is besloten om uw buikwand te corrigeren, omdat deze slap en uitgerekt is. Deze folder geeft informatie over de operatie adviezen voor zowel in de periode voor de operatie als daarna.

Een slappe buik of hangbuik (ook wel “vetschort” genoemd) is hinderlijk bij het bewegen en ontsierend. De buik kan teruggebracht worden tot zijn “normale” vorm door de buikwand in te nemen. Operatieve correcties van een hangbuik moeten dus niet gezien worden als een mogelijkheid om extra gewicht kwijt te raken. Integendeel, bij overgewicht moet men eerst proberen op een “normaal” gewicht te komen. Overgewicht beïnvloedt het resultaat van de operatie nadelig, het vergroot namelijk de kans op complicaties zoals nabloedingen, infecties en wondgenezingsprocessen.

Uw plastisch chirurg heeft een buikwandcorrectie geadviseerd, omdat hij/zij van mening is dat uw klachten (dit is per persoon verschillend) waarschijnlijk verholpen kunnen worden door deze operatie.

## Aanleiding tot een buikwandcorrectie

Bij ieder mens wordt de buik in de loop der tijd slapper door natuurlijk verlies van de elasticiteit van de huid. Dit varieert per persoon en wordt mede beïnvloed door onder andere lichaamsbouw, lichaamsgewicht en eventuele zwangerschappen.

Bij mensen die erg dik geweest zijn en vervolgens vele kilo’s zijn afgevallen kan een zogenaamd “vetschort” ontstaan. Hierbij hangt de uitgerekte buik als een schort aan de onderbuik.

Klachten van een slappe buik of hangbuik kunnen zijn:

- schaamte,
- ten onrechte aangesproken worden op zwangerschap,
- rugpijn ten gevolge van een verkeerde belasting van de lendespieren,
- hygiënische problemen zoals het smetten van de huid van de onderbuik.

## Doel van de operatie

De uitgerekte buikwand en/of hangbuik (het “vetschort”) wordt gecorrigeerd. Dat wil zeggen dat er overtollig huid en onderhuids vet wordt weggenomen. Tevens kan het noodzakelijk zijn de buikwand te verstevigen.

## De ingreep

### Conventionele buikwandplastiek zonder/met navelverplaatsing

Bij deze ingreep wordt er een horizontale snee gemaakt boven de schaamstreek in de onderbuik. De buikhuid wordt met het onderhuidse vetweefsel losgemaakt. Indien u alleen een huid-vetoverschot heeft bij de onderste buikhelft, wordt de huid tot onder de navel losgemaakt. Het overtollige huid-vetoverschot wordt weggehaald en de wond wordt gehecht. De navel wordt hierbij niet losgemaakt en verplaatst.

Indien u een huid-vetoverschot heeft aan de onder- en bovenbuik wordt de buikhuid met het onderhuidse vetweefsel tot aan de ribbenboog losgemaakt. De navel wordt ‘vrij’ gemaakt van het stuk huid dat weggehaald wordt en blijft via een steeltje met de buikspieren verbonden. Het teveel aan huid wordt met het onderhuids vetweefsel weggehaald en de wond wordt gehecht. Er wordt een sneetje gemaakt op de plaats waar de navel moet komen. De navel wordt hier vastgehecht aan de omliggende huid.

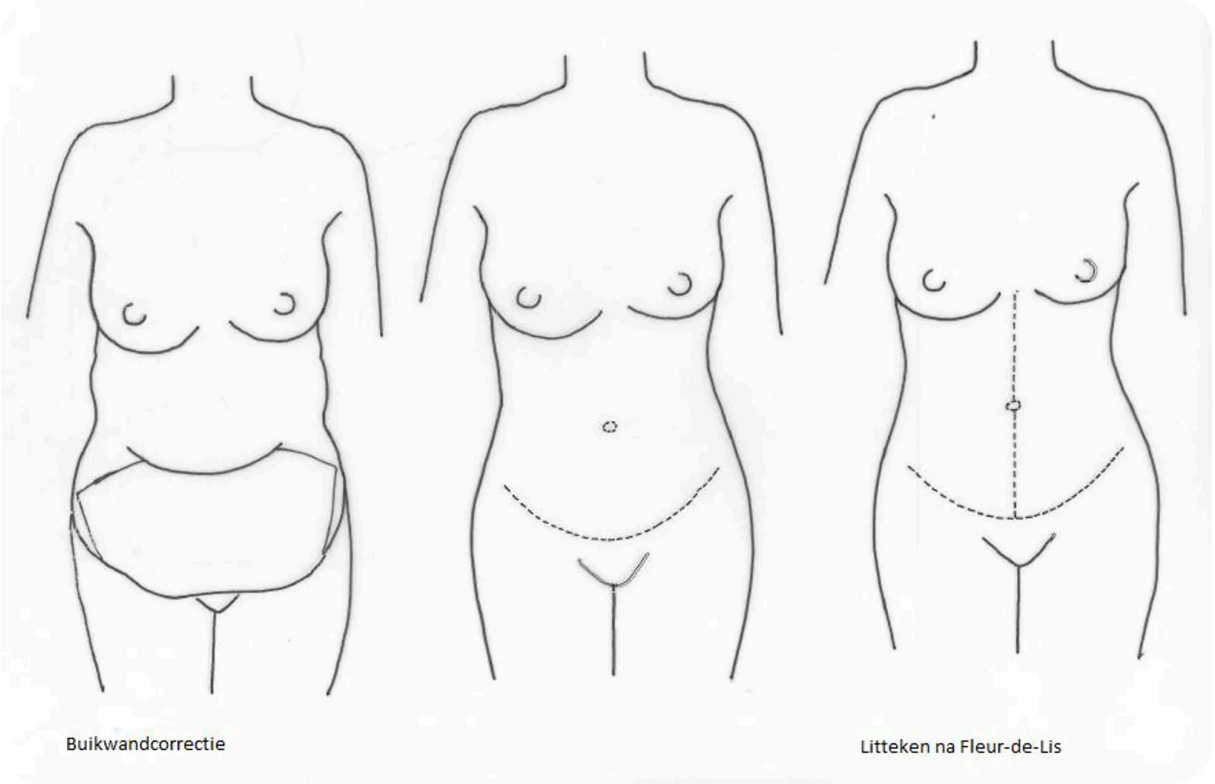
Als de schaamheuvel ook is gaan hangen na fors afvallen dan wordt bij de buikwandplastiek ook direct een mons pubis/veneris lift uitgevoerd. Hierbij zullen er geen extra littekens ontstaan, naast de littekens van de buikwandplastiek.

## Inverted-T/ Fleur-de-lis buikwandplastiek

Als er sprake is van een fors huid-vetoverschot en verlies van contour van de taille, dan is deze ingreep geschikt. Hierbij wordt dezelfde techniek als hierboven beschreven gebruikt en daarbij wordt er een snee van het schaambeen naar het borstbeen gemaakt. Hierna wordt er een verticale wig van het huid-vetoverschot weggehaald. Bij het sluiten van de wond wordt hierdoor het weefsel in de flanken naar het midden getrokken en ontstaat er weer een taille. De navel wordt in het verticale deel van de snee vastgehecht aan de omliggende huid.

## Circulaire/circumferentiële buikwandplastiek

Bij een huid-vetoverschot van de buik, flanken en billen wordt het litteken boven de schaamstreek in de onderbuik doorgetrokken naar de rug. Hierna wordt het overtollige huid-vetweefsel van de buik en rug/billen weggehaald. U krijgt hierna dus een litteken die rondom het lichaam loopt, ter hoogte van de onderbroekrand.



## Voorbereidingen thuis

- **Medicatie:** Gebruikt u bloedverdunners? Meld dit bij uw arts. Bloedverdunners kunnen tijdelijk worden gestopt. Stop medicatie alleen in overleg met uw arts of anesthesioloog.
- **Voeding:** Voor een goed wondherstel na de operatie helpt het als u vooraf een goede eetpatroon en conditie heeft. Om dit te ondersteunen kunt u extra eiwitten eten en eventueel vitamine C1000 slikken. Hiermee kunt u 2 weken voor de operatie starten en tot 1 week na de operatie doorgaan.
- **Roken:** Stop minstens 3 maanden vóór en 3 maanden na de operatie met roken om wondgenezingsproblemen te voorkomen.
- **Praktisch:** Neem een pyjama mee met knoopsluiting voor gemak bij wondverzorging. Regel hulp in huis voor de eerste weken na de operatie.
- **Nuchter zijn:** Volg de instructies die u krijgt van de anesthesioloog over niet eten en drinken voorafgaand aan de operatie
- **Autorijden** wordt absoluut afgeraden in de eerste weken na de ingreep. Zorgt u ervoor dat u vervoer geregeld heeft voor als u weer naar huis mag.
- Wij raden u aan om 24 uur voor tot 24 uur na de ingreep geen **alcohol** te drinken.

## Hoe verloopt de operatie?

U wordt op de dag van de operatie opgenomen. U moet dan nuchter komen. Dit zal verder uitgelegd worden door de anesthesist. De operatie vindt plaats onder narcose. De plastisch chirurg tekent voorafgaand aan de operatie op uw huid waar de littekens komen. Vóór en 3 maanden na de operatie worden medische foto's gemaakt voor uw dossier. De operatie duurt 1,5 tot 2 uur.

## Na de operatie

De buik wordt gesloten met oplosbare hechtingen en er worden meerdere drains geplaatst. Een drain is een slangetje dat vocht en bloed in het wondgebied afvoert om zo opeenhoping ervan tegen te gaan. Zo wordt druk op de wond voorkomen. Vaak wordt de drain al tijdens de opname verwijderd. Soms wordt de drain meegegeven naar huis en later op de polikliniek verwijderd. Om het tromboserisico te verlagen krijgt u in de avond een prikje met anti-stollingsmedicatie (Fraxiparine). Vanaf de operatiekamer heeft u een strakke buikband om gekregen die steun geeft. Dit ondersteunt de wond en voorkomt vochtophoping in de onderbuik. Door het trekken van de wond is het mogelijk dat u de eerste 2 weken niet rechtop kan lopen. Voor in bed adviseren we een strandstoelhouding aan te nemen.

In principe mag u na 1 dag weer naar huis. Bij ontslag krijgt u een afspraak voor controle op de polikliniek Plastische chirurgie mee.

## Risico's en complicaties

Na elke operatie, hoe zorgvuldig uitgevoerd ook, kunnen complicaties optreden. Voor deze operatie zijn dat:

- Een **allergische reactie** op gebruikte verdovingsvloeistoffen of materialen.
- **Wondproblemen** zoals het open gaan van de wond of vertraagde wondgenezing.
- **Littekens** die dik, strak of pijnlijk kunnen worden.

- **Bloeduitstortingen** komen regelmatig voor na deze ingreep en zullen binnen een aantal weken afnemen.
- Na deze operatie kan het gevoel in er operatiegebied verminderd zijn. In enkele gevallen keert het gevoel rondom de littekens niet (volledig) terug.
- Bij een **nabloeding** merkt u dat het wondgebied in korte tijd erg zwelt (en soms blauw wordt). In geval van een nabloeding dient u opnieuw geopereerd te worden om de bloeding te stelpen.
- **Vochtophoping** onder de huid (seroom).
- **Diep veneuze trombose of longembolie**: tijdens de operatie kan er een bloedpropje ontstaan, die later kan losschieten. Door te bewegen na de ingreep kunt u zelf het tromboserisico verlagen.

Deze risico's en complicaties, evenals het belang van stoppen met roken, zijn tijdens het gesprek met uw arts uitgebreid met u besproken. Hoewel de operatie met grote zorg wordt uitgevoerd, verschilt het genezingsproces per persoon, en daarom kunnen we geen garanties geven.

## Adviezen na de ingreep

- Uw wonden zijn gesloten met oplosbare hechtingen. Soms zitten hier pleisters overheen geplakt, dan mag u deze laten zitten tot het aan de controleafspraak.
- In het ziekenhuis krijgt u een buikband ter ondersteuning van de buik. Deze draagt u 6 weken dag en nacht. Thuis kunt u deze eventueel vervangen voor een step-in of andere stevige tailleslip.
- In bed moet u de eerste weken in 'strandstoel houding' liggen. Als uw bed thuis deze mogelijkheid niet heeft kunt u hiervoor bij de thuiszorg een matrasondersteuner huren.
- U mag douchen, maar **géén** ligbaden tot de wonden helemaal genezen zijn.
- Als alle wonden na minimaal 6 weken genezen zijn, mag u weer zwemmen of naar de sauna.
- Na een week of 4 mag u de wonden, mits gesloten, insmeren met olie of littekencrème. Advies hierover krijgt u op de polikliniek.
- Autorijden en fietsen kan doorgaans weer na een week of 4, als u voelt dat u dat verantwoord kunt.
- Gedurende 6 weken niet zwaarder tillen dan 5 kg, niet sporten en geen zwaar huishoudelijk werk verrichten (stofzuigen, ramen zemen, strijken of een boodschappentas tillen). Lichte activiteit zoals wandelen is toegestaan.
- Na 6-8 weken heeft u in principe geen beperkingen meer, u kunt dan ook weer sporten.
- Bovenstaande is natuurlijk wel op geleide van uw herstel en klachten.
- Het is belangrijk om uw litteken zo lang het rood is, niet bloot te stellen aan ultraviolet licht (zon of zonnebank). U kunt het litteken beschermen met een pleister of in een later stadium met een hoge zonnebrandfactor.
- Wij raden u aan om 3 maanden na de operatie niet te roken.
- Gaat u naar huis met de wonddrain? Dan krijgt u op de verpleegafdeling instructies en de folder 'Naar huis met wonddrain (redondrain)' mee.

## Het te verwachten resultaat

Meestal is de buik plat na de operatie. Er blijft wel een zichtbaar litteken. Omdat de huid tijdens de operatie over een groot gedeelte is losgemaakt, is het gevoel in de buikwand enige tijd nagenoeg verdwenen. Dit herstelt zich in de loop van het jaar vrijwel geheel of grotendeels. Het aanraken van de buikwand geeft in het begin een vreemd gevoel.

## De kosten

Of uw zorgverzekeraar de operatie vergoedt, hangt af van de polisvoorwaarden en de medische indicatie. De machtiging voor opname en operatie moet derhalve worden aangevraagd. Mocht het echter gebeuren dat u de operatie zelf moet bekostigen, dan kunt u een offerte opvragen bij het secretariaat van de polikliniek Plastische chirurgie.

## Wanneer neemt u contact op?

- Bij koorts (38.5° C of hoger) en/of niet lekker voelen.
- Plotselinge enorme zwelling van de buik.
- Uitblijven van de ontlasting.
- Roodheid van de huid rondom de wond.
- Wanneer de wond veel nabloedt, open gaat of veel vocht gaat lekken.
- Plotseling optredende benauwdheidsklachten.
- Als één van bovenstaande symptomen zich voordoet, kunt u contact opnemen met uw eigen. ziekenhuislocatie: locatie Den Haag of locatie Zoetermeer.

### Contactgegevens

Krijgt u bovenstaande klachten in het weekend, ’s avonds of ’s nachts, neem dan contact op met:

- Spoedeisende Hulp (SEH) Den Haag: 070 – 210 20 60
- Spoedeisende Hulp (SEH) Zoetermeer: 079 – 346 25 39

## Tot slot

Indien u vragen heeft na het lezen van de folder of na de ingreep kunt u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie. Bij nood, buiten kantooruren, kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp.

Van maandag tot en met vrijdag tijdens kantoortijden (8.00 - 16.00 uur) neemt u contact op met de Polikliniek Plastische chirurgie:

- Locatie Den Haag: 070 – 210 7760
- Locatie Zoetermeer: 079- 346 2804

## Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

### Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

### Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

### Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

### Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

508108012026